

Planuj *żeby nie decydować w głodzie*

Plan tygodniowy + lista zakupów + przygotowanie. Redukcja decyzji w momencie głodu — gdy mózg jest najbardziej impulsywny. Po 4–6 tygodniach staje się nawykiem.

CZAS: 20 min · wdrożenie · 1× / tydzień · Od sesji 2–3 · z regularnym jedzeniem 3+2

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Waller i in. (2007, *handbook CBT-E*)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **sześć elementów meal planningu** (sekcja 1), zobacz **typowe pułapki** (sekcja 2). Sekcja 3 — Twój plan tygodniowy. Sekcja 4 — lista zakupów.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Regularne jedzenie 3+2 wymaga **planowania**. Osoby z bulimią często mają chaotyczne jedzenie, ponieważ *nie planują* — jedzą „co akurat jest” (co często oznacza: epizod wieczorem z kuchni pełnej przypadkowych jedzeń). Fairburn (2008): planowanie posiłków obniża **obciążenie poznawcze** w momencie głodu — to wtedy mózg jest najbardziej **impulsywny** i najmniej zdolny do dobrych decyzji. „Co zjeść?” w stanie głodu często kończy się głodówką lub epizodem. Plan tygodniowy **eliminuje** tę decyzję — wiesz z *wyprzedzeniem*, co jesz na każdej z pięciu okazji. Lista zakupów chroni przed **impulsywnymi zakupami** (nigdy nie idź na zakupy *głodny/-a*). Po 4–6 tygodniach planowanie staje się **nawykiem**.

01 = Sześć elementów meal planningu

1 · PLAN TYGODNIOWY

W niedzielę (lub innym ustalonym dniu) planujesz **obiady i kolacje** na cały tydzień. Śniadania i przekąski mogą się powtarzać (rytmika).

2 · LISTA ZAKUPÓW

Wynika z planu. Robisz raz w tygodniu, najlepiej **nie głodny/-a**. Trzymaj się listy — nie kupuj impulsywnie.

3 · PRZYGOTOWANIE WCZEŚNIEJ

Część posiłków przygotuj z *wyprzedzeniem* (obiad do pracy, przekąski do torebki, kanapki na rano). Redukuje stres porannego pośpiechu.

4 · ELASTYCZNOŚĆ, NIE RYGOR

Plan to *ramy*, nie sztywne reguły. Można zamienić obiad środy z czwartkiem, można pójść na obiad do znajomych. Plan ma pomagać, nie obciążać.

5 · BACKUP W SZAFCE

Zawsze miej **dwa „plany B”** — szybkie posiłki na wypadek, gdyby plan zawiódł (puszka, mrożonka, kanapka). Brak backupu = ryzyko głodówki lub epizodu.

6 · TYGODNIOWY REVIEW

Raz w tygodniu (z terapeutą lub samodzielnie): co zadziałało, co nie? Co wymaga modyfikacji? Z czasem znajdziesz swój rytm.

02 ✗ Typowe pułapki — jak omijać

PLAN ZBYT SZCZEGÓŁOWY

„15 g płatków + 200 g mleka” — to **kalorie w ukrytej formie**. Plan ma być ogólny.

PLAN JAKO REGUŁA SZTYWNA

Myślenie *wszystko-albo-nic*. Plan to *narzędzie*, nie obowiązek.

ZAKUPY NA GŁODNO

Głód aktywuje impulsywne kupowanie

BRAK BACKUPU

„Nic nie zaplanowałem/-am, więc nic nie jem” → epizod. Zawsze miej coś na „plan B”.

03 \ Mój plan tygodniowy

Wpisz **ogólnie**, co planujesz na każdy dzień. Bez gramów, bez kalorii. Śniadania i przekąski mogą się powtarzać — to OK, nawet pożądane (mniej decyzji).

DZIEŃ	ŚNIADANIE	OBIAD	KOLACJA	PRZEKĄSKI
Pon.				
Wt.				
Śr.				
Czw.				
Pt.				
Sob.				
Niedz.				

04 \ Lista zakupów

CO KUPIĆ W TYM TYGODNIU

— wynika z planu; podstawy + backupy

BACKUPY W SZAFCE / LODÓWCE

— „plan B” — co mam na wypadek braku czasu lub energii

Klucz: meal planning to *nie* kontrola, to **infrastruktura**. Plan zwalnia mózg z konieczności podejmowania decyzji w *głodzie* — czyli wtedy, gdy jest najmniej zdolny do dobrych decyzji. To także **obniżenie obciążenia poznawczego** w ciągu dnia: nie musisz myśleć „co zjem na obiad”, bo wiesz to z niedzieli. Fairburn (2008): pacjenci z bulimią, którzy regularnie planują posiłki, mają **2x mniejsze** ryzyko epizodów w ciągu dnia. Wansink (2006): zakupy z *listą* obniżają impulsywne kupowanie o 30–50%. Zakupy *głodny/-a* zwiększają je o tyle samo. To prosta zasada, której konsekwencja jest ogromna. **Po 4-6 tygodniach** meal planning staje się nawykiem — nie potrzebujesz już szczegółowego planu, wystarczy ogólny szkielet. Niektórzy pacjenci kontynuują planowanie przez lata, inni wycofują je do minimalnej formy. Każda forma jest dobra, jeśli działa.